

إسم المريض ربيعاً : ورده علي سعيد علي
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : ابوالنمرس
رقم البطاقة : 28101172104441 رقم التليفون : 01110763858
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-01-1981 المهنة : ربه منزل
العنوان : ترسا
تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / 2 ----- / 2 ----- / 2.1 ----- / 2.1

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 جهة العلاج :
 نفقات :
 ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ورده علي سعيد علي National ID: 28101172104441	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



طلب علاج أول مرة / متردد

جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

إسم المريض ربيعاً : ورده علي سعيد علي
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : ابو النمرس
العنوان : ترسا
رقم البطاقة : 28101172104441 رقم التليفون : 01110763858
العمر (تاريخ الميلاد) : 17-01-1981 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 02-04-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : اشعة مقطعية على الصدر بالصبغة قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة



الاسم: د/احمد نجيب الوظيفة: -----
الاسم: د/خالد عبدالعزيز الوظيفة: -----
الاسم: د/ محمد كيلاني الوظيفة: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص



٢٠٢٤/٠١
٢٨٨٠١١٧٣١٠٤٤٤١
رَبِّهِ مَنْزِلُ
مَسَلَّةُ
مَرْجُوَّةُ
مَحْمُودُ مَصْطَفَى مَحْمُودُ مَصْطَفَى
٢٨٣٨/٠١/٢٧
البطاقة سارية حتى



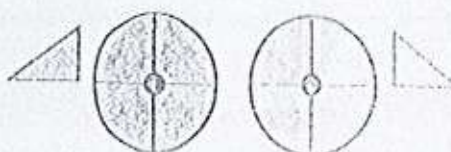
Name: ورده علي سعيد علي		
MR. : 4714		
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient was prescribed FEMARA and calcium supplementation at a dose of 1 tablet daily (1*1*90) with a single alpha formulation for breast disease, and a chest CT was ordered for further evaluation. The patient continued on FEMARA and calcium 1 tablet daily (1*1*90) with a single alpha formulation for SM; a follow-up appointment was scheduled for 26/3/2026, and a chest CT was pending. ZolaDEX was noted at a dose of 10.8 SC to be administered on 29/4/2026. The patient has a history of premorbid right-sided breast cancer, invasive ductal carcinoma, estrogen receptor 4/8, progesterone receptor 4/8, HER2 2+, clinical stage T3 N1 M0. The patient has had a hemangioma since diagnosis, confirmed by MRI. Neoadjuvant therapy consisted of TAXOL-CARBO for 4 cycles followed by AC for 4 cycles, initially managed as triple-negative disease, then proceeded to radiotherapy (MRM) and placement of a port. A multidisciplinary team recommended continuation with FEMARA and ZolaDEX; the patient has been receiving this regimen for six months. A CT scan of the chest, abdomen, and pelvis performed on 23/4/2026 demonstrated stable disease of a hepatic lesion with otherwise no detectable disease. The patient is currently free of disease and continues on FEMARA plus ZolaDEX.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد	
يعتمد ,		

MDT FORM ٢٧.٩ / 20٢٠ G

Name	وردة علي سعيد	MRN	C909 / C2
Age	Pre	ID	0111309676
Menopausal status		Phone	
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	Post op
CO morbidity		REASON OF MDT	
CM-11701-4441			

Clinical Data

BX:	IDC			R			
ER:	1/8	PR:	4/8	HER 2:	-ve	Ki67:	
Sonomammography: C T3 N1 M?							
NACTH: AC X4 DD							
T.C. X12							
Mets Marked: S/202S							
PToN116Mo							
For Adj tht							



TNM

Recommendations:

(Xeloda refused by MoH)

MDT OUTCOME & PLAN

MoH Refused xeloda

Adj. Adx. A2 + 2 cycles of POC

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
[Signature]					



Patient Name: Warda Ali Saced Ali	Date : 22/04/2025
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 2909/2024	Pat. ID: 79501

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Post NACT status of right breast malignant mass

Report:

- Heterogeneously dense breasts; may obscure small lesions (ACR C)
- Right Breast:
 - Marked regression of the previously noted dense mass seen in the right axillary tail. It measures 10x8mm compared to 40x30mm about 120mm from the nipple. It is seen by U/S as hypoechoic circumscribed hypoechoic rounded mass about 6mm from the skin.
 - Resolved previously noted other smaller masses.
 - Indeterminate single level I axillary lymph node.
 - No pathological enlarged infra or supraclavicular lymph nodes.
- Left Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post NACT right breast pathologically proven malignant masses showing very-good response to therapy (BIRADS 6)
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,

NCI, Cairo University

22/04/2025 3:52 PM

Patient Name: Warda Ali Saeed Ali
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
Medical ID: 2909/2024

Date : 07/05/2025
Age: 44 Year(s)
Pat ID: 79501

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size (15cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.
- Multiple hyperechoic focal lesions , the largest is seen at segment V measuring 22x20mm
- No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexal: no abnormalities could be detected

Opinion:

Hepatic focal lesions likely hemangiomas

Signature Dr Nermien Ramadan

07/05/2025 12:31 PM

Patient Name	: الأستاذ / وردة على مسعود على	Request No.	: 13009633
Patient No.	: 28101172104441	Request Date	: 07/08/2024
Birth No.	: 2825/24	Verification Date	: 28/08/2024
Sex	: Female	Financial Category	: جوسلف روسى - ميانره
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast swelling.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 7/08/2024.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), SISH & Ki67 clone (30-9).

Results:

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Moderate nuclear reaction in 5% of tumor cells (score 4/8).
PR: Faint nuclear reaction in 15% of tumor cells (score 4/8).
Her2: Strong complete membrane reaction in <10% of the tumor cells (score 2+).
SISH: Not amplified.
Average Her2 copy number: 1.7.
Her2/CEP 17 ratio: 0.97.
Ki67: 40% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Right breast swelling, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade III.

IPT:

ER: Positive (score 4/8).
PR: Positive (score 4/8).
Her2: Equivocal (score 2+).
SISH: Not amplified.

Verified by :



Patient Name: Warda Ali Saeed Ali
Exam : CT CAP(CT Chest Abd. Pelvis)
Medical ID: 2909/2024

Date : 08/09/2025
Age : 44 Year(s)
Pat. ID: 79501

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction.

FINDINGS:

Status post right mastectomy showing:

(I) Chest:

- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- Subcentimetric mediastinal lymph nodes are noted.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size, showing homogenous CT density with right hepatic lobe segment 5 hypodense focal lesion , measuring 28x26x14 mm in diameter.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Pelvic phleboli are noted.